

Syndrome des Anti-Phospholipides (SAPL)

I/ INTRODUCTION – DEFINITION

- Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est une **maladie auto-immune** caractérisée par la présence d'**anticorps** (à un *taux significatif*) **dirigés contre des phospholipides** ou **des protéines liant les phospholipides**, présents sur les membranes cellulaires.
- Les cibles de ces anticorps sont principalement :
 - La **cardiolipine** (un phospholipide mitochondrial).
 - La **β 2-glycoprotéine 1 (β 2-GP1)** : protéine plasmatique se liant aux phospholipides.
 - **NB** : les anticorps anti-cardiolipine et anti- β 2-GP1 sont **pathogènes** et sont donc responsables des manifestations cliniques.
- Le SAPL peut se présenter sous deux formes :
 - **SAPL primitif** : isolé sans association à une autre maladie auto-immune.
 - **SAPL secondaire** : associé le plus souvent à un **lupus érythémateux systémique (LES)**, plus rarement à un **syndrome de Gougerot-Sjögren** ou à d'autres connectivites.

Le diagnostic du SAPL est clinico-biologique.

II/ MANIFESTATIONS CLINIQUES :

1/ Manifestations thrombotiques :

- Elles sont au premier plan au cours du SAPL et se produisent **spontanément, sans facteur favorisant** ni contexte évocateur (chirurgie, alitement, contraception, etc.).
- Les thromboses peuvent survenir dans tous les territoires vasculaires :
 - **Veineux** : veines profondes des membres inférieurs, veine cave supérieure/inférieure, thromboses ovariennes, embolies pulmonaires, thromboses veineuses superficielles, etc.
 - **Artériels** : artères cérébrales (AVC), coronaires (IDM), artères mésentériques, ischémie digitale, gangrènes, etc.
 - **Microvasculaires** : capillaires, artéioles, entraînant des atteintes d'organes multiples.
- Ces thromboses sont souvent **disproportionnées à la clinique** et leur **siège inhabituel** est un élément évocateur.
- **NB** : Tout **AVC ou IDM chez un sujet jeune** doit systématiquement faire évoquer et rechercher un SAPL.

2/ Manifestations obstétricales : probablement secondaires à une insuffisance placentaire par thromboses, elles sont un **critère diagnostique fondamental** du SAPL :

- **≥ 3 fausses couches précoces** (< 10 SA), **spontanées, consécutives, sans cause identifiée** (béance du col, aberrations chromosomiques).
- **Ou ≥ 1 mort foetale in utero** (> 10 SA), non expliquée.
- **Ou une prématurité inexpliquée.**

3/ Manifestations cardiaques (valvulaires) : principalement l'**endocardite de Libman-Sacks** :

- Végétations stériles sur les valves, en particulier la valve mitrale.
- Risque de greffe bactérienne secondaire (endocardite infectieuse).
- Risque d'embolisation systémique à distance (AVC, ischémies périphériques).

4/ Manifestations cutanées : fréquentes et évocatrices du SAPL :

- Livedo racemosa : vascularite des petits vaisseaux, à **grosses mailles, violacées**, persistantes à la chaleur.
- Nécroses cutanées : par occlusion artérielle distale (zones d'ischémie).
- Ulcérations cutanées : suite à des thromboses des petits vaisseaux cutanés
- Hémorragies en flammèches sous-unguéales : reflet d'une atteinte microvasculaire.

- Anéto dermie : rare mais **quasi pathognomonique**, liée à une thrombose des vaisseaux dermiques responsables d'une **destruction localisée (nécrose) des fibres élastiques** de la peau (aspect de **vergetures fines**).

III/ BILAN BIOLOGIQUE :

1/ Anomalies hématologiques :

- Thrombopénie modérée : typiquement entre **80 000 et 100 000/mm³**, souvent par **consommation périphérique**, elle est **fréquente**, non sévère, **bien tolérée**, mais **très évocatrice** dans le contexte.
- Anémie hémolytique mécanique :
 - Rare, mais possible, notamment dans les formes graves comme le **SAPL catastrophique**.
 - Présence de **schizocytes** (fragments de GR), traduisant une **destruction intravasculaire**.

2/ Autres anomalies :

- TCA allongé (Temps de Céphaline Activée) : explorant la voie endogène de la coagulation :
 - Causé par la présence d'un **anticoagulant circulant lupique (ACC)** : auto-anticorps dirigés contre les complexes phospholipides-protéines.
 - Cet anticorps présente un effet **anticoagulant in vitro** (d'où le TCA allongé), mais **pro-coagulant in vivo**, car il active la coagulation sur l'endothélium, d'où **la survenue de thromboses**.
 - Le TCA **n'est pas corrigé** par l'adjonction d'un plasma témoin : ceci confirme **l'origine auto-immune** (contrairement au déficit en facteurs de coagulation).
- Sérologie syphilitique faussement positive :
 - TPHA – / VDRL + : association caractéristique.
 - Fausse positivité du VDRL due à la réaction croisée des anticorps antiphospholipides avec les antigènes cardiolipiniques utilisés dans le test.
 - Ce résultat **doit faire évoquer un SAPL** en l'attente du bilan immunologique.
- Atteinte rénale : dans les formes sévères (microangiopathie thrombotique), il peut exister :
 - Une **insuffisance rénale aiguë ou chronique**, liée à des thromboses des artérioles rénales.
 - Un tableau de **néphropathie thrombotique** : protéinurie, hématurie, hypertension artérielle.

IV/ CRITERES DIAGNOSTIQUES : Le diagnostic de SAPL repose sur une association obligatoire d'au moins un critère clinique et un critère biologique (immunologique), ce dernier devant être **confirmé à 12 semaines d'intervalle** pour affirmer la persistance et écarter un faux positif transitoire.

1/ Critères cliniques :

- Manifestations thrombotiques :
 - **Thromboses veineuses, artérielles** ou de la **microcirculation**, **sans facteur déclenchant identifié**.
 - Tous les territoires peuvent être atteints : **TVP, EP, AVC, IDM**, etc.
- Manifestations obstétricales (par thromboses placentaires et éclampsies) :
 - **≥ 3 fausses couches précoces (< 10 SA)**, spontanées et consécutives, **sans cause identifiée**.
 - **≥ 1 mort fœtale in utero (> 10 SA)**, **non expliquée**.
 - **Accouchement prématuré** avant 34 SA, **inexpliqué**.

2/ Critères biologiques : les anticorps doivent être présents de manière **persistante** à 12 semaines d'intervalle:

- **Anticorps anti-cardiolipine (IgG ou IgM)**
- **Anticorps anti-β2-glycoprotéine 1 (IgG ou IgM)**
- **Anticoagulant circulant lupique (ACC)** : responsable du TCA allongé non corrigé

Un **SAPL séronégatif** est possible, lié à des anticorps non dosables actuellement, le diagnostic est alors **clinique**, d'élimination. 3

V/ SITUATIONS ASSOCIEES AUX ANTICORPS ANTIPHOSPHOLIPIDES (APL) :

- Les anticorps antiphospholipides peuvent être retrouvés *en dehors d'un SAPL avéré*, dans de nombreuses situations pathologiques ou même chez des sujets asymptomatiques.
- Il est donc essentiel de **ne pas conclure à un SAPL** sur la seule base d'un bilan immunologique positif.
- Il est à noter que le traitement de la pathologie associant ces APL, ou l'arrêt du médicament en cause permettra de faire disparaître le syndrome des anti-phospholipides associé.

1/ Associations pathologiques fréquentes :

- SAPL secondaire au lupus (association la plus fréquente)
- Syndrome de Gougerot-Sjögren, sclérodermie systémique, pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR)
- Maladie de Horton, sarcoïdose
- Spondylarthrite ankylosante (SPA), maladie de Crohn

2/ Situations infectieuses associées : les infections peuvent induire transitoirement des APL :

- Viroses aiguës (EBV, CMV, parvovirus B19, etc.)
- VIH, hépatite C, syphilis (faux positifs VDRL)
- Tuberculose
- Borréliose (Maladie de Lyme).

3/ Causes médicamenteuses :

- Bêta-bloquants (ex : propranolol)
- Autres médicaments plus rarement impliqués : hydralazine, phénytoïne, etc.

4/ Pathologies néoplasiques :

- Cancers solides (surtout digestifs et gynécologiques)
- Hémopathies malignes (lymphomes, leucémies)
- Gammapathies monoclonales / immunoglobulines monoclonales

5/ Autres états cliniques :

- Présence isolée d'APL : chez un patient asymptomatique, sans manifestation thrombotique ni obstétricale : la hantise est de ne pas traiter
- Diabète
- Insuffisance rénale chronique

VI/ SYNDROME CATASTROPHIQUE DES ANTIPHOSPHOLIPIDES (SCAPL) : Le syndrome catastrophique des antiphospholipides est une **forme rare, aiguë, et gravissime** du SAPL, nécessitant une **prise en charge en urgence**.

1/ Caractéristiques principales :

- Il est révélateur du SAPL dans la moitié des cas.
- Dans les autres cas, un facteur déclenchant est le plus souvent mis en évidence (infection, chirurgie ou autre mesure invasive, arrêt, relais ou accident des anticoagulants, des anticoagulants ou INR trop bas...).
- C'est une urgence diagnostique et thérapeutique absolue.
- Mortalité très élevée si non prise en charge rapide (40-50%)
- Mécanisme : activation massive de la coagulation entraînant une **microangiopathie thrombotique (MAT)** sévère et multiviscérale

2/ Critères diagnostiques : Il existe une classification internationale ayant fait l'objet d'un consensus en 2003 fondé sur les 4 critères suivants, qui lorsqu'ils sont réunis, le diagnostic de SCAPL devient **certain**.

1. Atteinte d'au moins 3 organes, systèmes et/ou tissus
2. Survenue des symptômes simultanément ou en moins d'une semaine
3. Confirmation anatomopathologique d'une occlusion de petits vaisseaux dans au moins un organe ou tissu.
4. Confirmation biologique de la présence d'anticorps antiphospholipides (présence d'un anticoagulant circulant de type lupique et/ou d'un anticorps anti-cardiolipines et/ou anti-β2-GP-1)

VII/ TRAITEMENT DU SAPL : Le traitement dépend de la **présentation clinique (thrombose, grossesse)** et vise à **prévenir les complications thromboemboliques et obstétricales**.

1/ Traitement de fond et prévention des récurrences :

- Antiagrégants plaquettaires (ex. aspirine) si APL sans thrombose mais facteurs de risque (permettent aussi la prévention des récurrences)
- Anticoagulants (AVK à dose curative) si antécédents thromboemboliques (les AOD sont à éviter).

2/ En cas de grossesse ou désir de grossesse :

- Aspirine à faible dose avant conception
- Héparine de bas poids moléculaire (HBPM) à dose **iso-coagulante (préventive)** dès le début de la grossesse et durant toute celle-ci afin de réduire le risque de fausse couche et de complications placentaires.
- Si cette héparinothérapie échoue et qu'il y a fausse couche, passer à une **dose curative** dès le début de la prochaine grossesse et la maintenir durant toute celle-ci.

3/ Hydroxychloroquine (Plaquénil®) :

- Utilisé surtout en cas d'association au lupus
- **Effet antithrombotique indirect** (immunomodulateur)
- Bien toléré à long terme, effet protecteur en prévention secondaire

CONCLUSION :

- Le syndrome des antiphospholipides est une maladie auto-immune caractérisée par la présence d'anticorps prothrombotiques qui exposent à des thromboses atypiques et à des complications obstétricales.
- Le diagnostic repose sur l'association de signes cliniques et d'anticorps spécifiques persistants.
- Le traitement anticoagulant est essentiel, avec une prise en charge adaptée en cas de grossesse ou de forme sévère.
- Une détection précoce et un suivi rigoureux sont indispensables pour limiter la morbi-mortalité liée à cette pathologie.